Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Septoplasti

Burun orta bölmesi (septum) eğriliğinin düzeltilmesi ameliyatı

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Birlikte yapılacak işlemler:
☐ Konka küçültme (radyofrekans / submukozal)
☐ Endoskopik sinüs cerrahisi — FESS (ayrı onam formuyla) ☐ Yok

Burun içi atel / tampon:
☐ Silikon atel ☐ Tampon ☐ Gerek görülmüyor
☐ Ameliyatta karar verilecek _____

Hastanın şikâyeti (tıkanıklık tarafı, horlama, baş ağrısı vb.): _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Burun boşluğunu sağ ve sol olarak ikiye ayıran, kıkırdak ve ince kemikten oluşan duvara **septum** denir. Septumun bir tarafa veya her iki tarafa eğri olmasına **septum deviasyonu** denir. Bu durum doğuştan, büyüme sırasında veya burna alınan bir darbe sonrası oluşabilir.

Eğri septum burun tıkanıklığına, ağızdan nefes almaya, horlamaya, uyku kalitesinde bozulmaya, ağız kuruluğuna, burun kanamalarına ve bazı kişilerde sinüzit ataklarına veya baş ağrısına yol açabilir. Yapısal bir sorun olduğu için ilaçlarla düzelmez. Septoplastinin amacı, eğri bölümleri düzelterek **burundan rahat nefes almanızı** sağlamaktır. Bu ameliyat burnun dış görünümünü değiştirmeyi amaçlamaz.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genellikle genel anestezi altında, ameliyathanede, tamamen burun deliklerinin içinden yapılır. Yüzde dışarıdan görünen bir kesi veya iz olmaz.

1. **Kesi:** Burun deliğinin içinde, septumu örten mukoza (burun içi zarı) üzerinde küçük bir kesi yapılır.
2. **Mukozanın kaldırılması:** Septumu iki taraftan örten zar, kıkırdak ve kemikten nazikçe ayrılır.
3. **Eğriliğin düzeltilmesi:** Eğri olan kıkırdak ve kemik parçaları çıkarılır, düzeltilir veya yeniden yerine konur. Burnun dış şeklini taşıyan destek bölümleri (burun sırtı ve ucunu tutan kıkırdak çerçeve) korunur.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

4. **Konkaların küçültülmesi (gerekirse):** Burun yan duvarındaki konka adı verilen yapılar büyükse, radyofrekans veya zarın altından doku azaltılması yöntemiyle küçültülür.
5. **Kapatma:** Mukoza kendi yerine yatırılır, eriyen dikişlerle tutturulur.
6. **Atel/tampon:** Septumun düz iyileşmesi ve kanamanın önlenmesi için burun içine genellikle ortası boş, nefes almaya izin veren yumuşak silikon ateller veya tamponlar yerleştirilir.

Septumun ön ve dış kısmı da eğri ise veya burnun dış şekli de tıkanıklığa katkıda bulunuyorsa, ayrı olarak konuşulup onaylanması koşuluyla rinoplasti ile birlikte (septorinoplasti) planlanabilir.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi (seçilmiş durumlarda lokal anestezi + sedasyon)	Yaklaşık 45–90 dakika	Aynı gün veya 1 gece hastanede kalış

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Burundan nefes almanın rahatlaması, ağızdan solunumun azalması
- Uyku kalitesinin artması, horlamanın azalması (horlamanın başka nedenleri de olabilir)
- Eğriliğe bağlı tekrarlayan burun kanamalarının ve bazı hastalarda sinüzit ataklarının azalması
- Gerekiyorsa sinüs veya diğer burun ameliyatları için yolun açılması

Yayınlarda hastaların yaklaşık **100'de 70–85'inin** ameliyattan sonra burun tıkanıklığının belirgin olarak azaldığını ifade ettiği bildirilmektedir. Tıkanıklığın alerji, mukoza şişliği, burun kanadı çökmesi veya sinüs hastalığı gibi başka nedenleri de varsa bu nedenlerin ayrıca tedavisi gerekebilir. Nadiren septum zamanla yeniden hafif eğrilebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak / beklemek:** Şikâyetleriniz hafifse yalnızca takip edilebilir.
- **İlaç tedavisi:** Kortizonlu burun spreyleri, burun yıkama ve alerji ilaçları mukoza şişliğini azaltarak şikâyetleri hafifletebilir; ancak kemik ve kıkırdaktaki yapısal eğriliği düzeltmez.
- **Burun bandı / burun deliği genişleticiler:** Geçici rahatlama sağlayabilir.
- **Dekonjestan (burun açıcı) spreyler:** Yalnızca birkaç günlük kullanım için uygundur; uzun süreli kullanım bağımlılığa ve daha fazla tıkanıklığa yol açar.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa septumdaki eğrilik kendiliğinden düzelmez; burun tıkanıklığı, ağızdan nefes alma ve horlama gibi şikâyetleriniz devam eder ve yaşla birlikte artabilir. Bu durum genellikle hayati bir tehlike oluşturmaz; ameliyat kararı şikâyetlerinizin yaşam kalitenizi ne kadar etkilediğine göre verilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri, gerekirse sinüs tomografisi ve diğer tetkikler yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- Ameliyattan önceki günlerde grip, nezle veya ateşli bir hastalık geçirirseniz bize bildiriniz; ameliyat ertelenebilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Burun içi ateller nedeniyle tıkanıklık hissi, hafif kanlı sızıntı, baş ağrısı ve boğaz kuruluğu olur. Ağrı genellikle hafiftir. Başınız yüksekte yatmanız önerilir. Burnun altına konan gazlı bez birkaç kez değiştirilebilir.
3–7. gün	Silikon ateller veya tamponlar genellikle **3–7. günler** arasında kontrolde çıkarılır; bu işlem kısa süreli bir rahatsızlık verir. Burun yıkamaya başlanır. Masa başı işe dönüş çoğunlukla 5–7 gün içinde olur.
2–4. haftalar	Burun içinde kabuklanma ve kuruluk olabilir; düzenli yıkama ile azalır. Nefes alma giderek rahatlar. Ağır egzersiz ve temas sporları yaklaşık **3–4 hafta** ertelenmelidir.
1–3. aylar	Burun içi zar tamamen iyileşir. Nihai nefes alma sonucu genellikle bu dönemde değerlendirilir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Ateller çıkana kadar burun tıkanıklığı ve ağızdan nefes alma
- İlk günlerde hafif kanlı sızıntı
- Üst ön dişlerde ve üst dudakta geçici uyuşukluk
- Burun içinde kabuklanma ve kuruluk (ilk haftalar)
- Koku almada geçici azalma

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Uzun süren kabuklanma ve kuruluk** — Özellikle konka küçültme yapıldıysa birkaç hafta sürebilir; yıkama ve nemlendirici merhemle geçer.
- **Üst dişlerde ve dudakta uzun süren uyuşukluk** — Genellikle birkaç hafta içinde düzelir; nadiren birkaç ay sürebilir.
- **Tıkanıklığın tam olarak geçmemesi** — Yaklaşık 100 hastadan **15–30'unda** nefes alma beklenen ölçüde düzelmeyebilir. Bunun nedeni çoğu zaman alerji, mukoza şişliği veya burun kanadı zayıflığı gibi ek etkenlerdir; ilaç tedavisi veya ek cerrahi gerekebilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Burun kanaması** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** tamponlama gerektiren kanama olabilir. Çok nadiren kanamanın ameliyathanede durdurulması gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Septum delinmesi (perforasyon)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** septumda delik oluşabilir. Çoğu zaman şikâyet yapmaz; ıslık sesi, kabuklanma veya kanamaya yol açarsa yıkama, septum düğmesi (buton) veya onarım ameliyatı gerekebilir.
- **Burun içi yapışıklık (sineşi)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–5'inde** septum ile yan duvar arasında yapışıklık gelişebilir; tıkanıklık yaparsa kontrolde basit bir işlemle ayrılır.
- **Septumda kan veya iltihap toplanması (hematom / apse)** — 100 hastada **1'den az** görülür. Ameliyattan sonraki günlerde artan tıkanıklık, ağrı ve ateşle belirti verir. Burun kıkırdağına zarar vermemesi için **acilen boşaltılması** gerekir; tedavi edilmezse kıkırdak kaybı ve burun sırtında çökme gelişebilir.
- **Enfeksiyon** — Nadirdir; genellikle antibiyotikle düzelir.
- **Eğriliğin tekrarlaması** — Kıkırdak hafızası nedeniyle septum zamanla tekrar hafif eğrilebilir; şikâyet oluşturursa ikinci bir ameliyat gerekebilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Burun sırtında çökme (semer burun)** — 100 hastada **1'den az** görülür. Septumun destek kıkırdağının zayıflaması veya hematom/apse sonrası kıkırdak kaybıyla burun sırtı çökebilir; burnun dış görünümünde değişikliğe yol açar ve düzeltilmesi için kıkırdak grefti ile ek ameliyat gerekir.
- **Burun ucunda düşme veya şekil değişikliği** — Çok nadirdir; destek yapılarının etkilenmesiyle oluşabilir.
- **Koku almanın kalıcı azalması veya kaybı** — Çok nadirdir.
- **Beyin-omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı ve menenjit** — Septumun üst kısmının kafa tabanına komşu olması nedeniyle **10.000'de 1'den çok daha az** görülen, son derece nadir bir komplikasyondur. Gelişirse hastanede yatış, ek tedavi ve onarım ameliyatı gerekebilir.
- **Boş burun sendromu** — Konkalar aşırı küçültülürse, burun açık olmasına rağmen tıkanıklık ve kuruluk hissi gelişebilir. Çok nadirdir; konkalar bu nedenle korunarak küçültülür. Gelişirse uzun sürebilir veya kalıcı olabilir ve tedavisi güçtür.
- **Toksik şok sendromu** — Burun içi tampon/atel kullanımına bağlı, çok nadir ancak acil tedavi gerektiren ciddi bir enfeksiyon tablosudur (ani yüksek ateş, döküntü, tansiyon düşüklüğü). Hastanede, gerekirse yoğun bakımda tedavi gerektirir ve hayatı tehdit edebilir.
- **Görme bozukluğu, göz çevresi kanaması** — Septoplasti ile son derece nadirdir; FESS gibi sinüs ameliyatlarıyla birlikte yapıldığında risk biraz daha yüksektir ve ayrı onam formunda anlatılır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Birkaç dakikalık baskıya ve buz uygulamasına rağmen **durmayan veya çok yoğun burun kanaması**, ağızdan sürekli kan gelmesi
- Ameliyattan sonraki günlerde **artan burun tıkanıklığı, burunda şiddetli ağrı ve şişlik** (septum hematomu/apsesi belirtisi olabilir)
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kötü kokulu akıntı
- Tampon/atel varken **ani yüksek ateş, ciltte döküntü, baş dönmesi veya halsizlik**
- Burundan, özellikle öne eğilince artan **berrak, sulu akıntı**, şiddetli baş ağrısı veya ense sertliği
- **Görmede bulanıklık, çift görme** veya göz çevresinde şişlik
- Nefes darlığı veya göğüs ağrısı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 2 hafta burnunuzu sümkürmeyiniz; hapşırırken ağzınızı açık tutunuz.
- Burun yıkamayı size gösterildiği şekilde, önerilen sıklıkta yapınız.
- İlk 2 hafta sıcak banyo, sauna, hamam ve ağır kaldırmaktan kaçınınız.
- Burnunuzu en az 4 hafta darbelere karşı koruyunuz.
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle ateller çıkarıldıktan sonra güvenlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Bu ameliyatın amacının burnun dış görünümünü değiştirmek değil, nefes almayı rahatlatmak olduğunu; tıkanıklığın başka nedenleri varsa ek tedavi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.